

Información Paciente

Nombre : Mariana Andrea Moreno Sandoval
Edad : 42a 4m 6d
Dirección : Narcos Perez 04958

Rut : 15.393.506-8
Fecha Nacto: 30/09/1980
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0018638
Sexo : Femenino
Teléfono : 1 2345 6789

N° Epicrisis
340349

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 25/01/2023 22:40
Fecha Egreso : 06/02/2023 11:02

Días Estadía: 12

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

shock

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS UCI

MARIANA ANDREA MORENO SANDOVAL
EDAD: 42 años
RUT: 15.393.506-8
Fecha ingreso CARS: 25-01-23
Fecha ingreso UCI: 26-01-23
Familiar mariana (madre): 984302084

ANTECEDENTES:

- ¿ DHC POR OH
- ¿ Policonsumo de sustancias (THC, Cocaína, Pasta Base)
- ¿ Tabaquismo crónico. 2-3 cajetillas diarias
- ¿ OH crónico
- ¿ Medicamentos: (-)
- ¿ Alergias (-)

Diagnósticos de ingreso a Urgencias

- Dolor abdominal en estudio / isquemia intestinal
- Falla hepática aguda sobre crónica (ACLF)

CUADRO ACTUAL:

Paciente con los antecedentes antes descritos.

Consulta al servicio de urgencias de esta institución por dolor abdominal y compromiso del estado general, a su ingreso destaca; encefalopatía, taquicardia, T°: 37,5 C. Se realiza TC de tórax y abdomen que revela: ¿Signos sugerentes de colitis isquémica del colon derecho, con dudosa isquemia mesentérica dependiente del íleon distal, al parecer no oclusivo, engrosamiento mural del colon e intestino que podría ser colopatía portal sin poder descartar origen isquémico. Extenso infarto

Fecha Epicrisis : 06/02/2023 11:27

Fecha Última Actualización: 06-02-2023 11:27:41

Página 2 de 3

hepático derecho con compromiso de segmento de LI, DHC asociado a marcadores de hipertensión portal, nefropatía médica bilateral, leve cardiomegalia.

Al laboratorio destaca: lactato 147,8 mg/dL (16,4 mol/L), Alb: 1,5, Bili T/D: 23,4/13,88. FA: 212, GGT: 96. SGOT: 441 SGPT: 60. Crea: 1,7. BUN: 17,1, Glucosa: 41. LDH: 993, PCR: 107. TP: 32%. INR: 2,16. TTPA: 53,9. Na: 133, K: 6,21. Cl: 101. HCT: 36,6%. Hb: 11,5. Leu: 12.270. Pla: 134.000.

En ese contexto ingresa a pabellón, según protocolo quirúrgico:

¿ Se extrae abundante líquido ascítico turbio, se toman muestras para cultivo,

¿ Se explora la cavidad evidenciándose asas con sufrimiento, pero sin necrosis, por lo que no es necesario resecar.

Ingresa a UCI en shock refractario y falla orgánica múltiple.

Diagnósticos de ingreso en UCI

· Shock Séptico de foco abdominal por E. Coli multisensible; peritonitis Bacteriana espontánea:

o Falla orgánica múltiple - SOFA 18 puntos

· Falla hemodinámica

· Falla respiratoria - SDRA

· Falla hepática

· Falla Renal KDIGO 3

o Hemodiálisis aguda

· Falla hematológica

· Falla hepática aguda sobre crónica (ACLF)

Intercurrencias

· Neumonía asociada a ventilación mecánica por SAMS

o Cloxacilina

· Shock hipovolémico ¿ sangrado digestivo / 05/02/2023

o Soporte transfusional

o Profundización de sus fallas orgánicas

Paciente en shock refractario y falla orgánica múltiple.

Requiere antibioticoterapia de amplio espectro, soporte vasopresor con tres drogas (adrenalina, noradrenalina y vasopresina) y terapia de reemplazo, logra estabilidad hemodinámica, persiste en falla renal con necesidad de TRR y en ACLF, muy frágil, se rescata E. Coli de líquido abdominal tomado en la cirugía, se dirige tratamiento antibiótico.

Intercurre con NAVM por SAMS, se dirige tratamiento antibiótico con Cloxacilina.

El 05/02/2023 intercorre con shock hipovolémico por sangrado digestivo alto, recibe terapia de soporte transfusional e inhibidores de bomba de protones, evoluciona con profundización de fallas orgánicas y falta de respuesta al tratamiento, en ese contexto fallece el 06/02/23 a las 11:15 H

Diagnóstico de Egreso

Sepsis -

Sepsis - Shock Séptico de foco abdominal por E. Coli multisensible; peritonitis Bacteriana espontánea:

o Falla orgánica múltiple - SOFA 18 puntos

· Falla hemodinámica

· Falla respiratoria - SDRA

· Falla hepática

· Falla Renal KDIGO 3

o Hemodiálisis aguda

· Falla hematológica

· Falla hepática aguda sobre crónica (ACLF)

Intercurrencias

· Neumonía asociada a ventilación mecánica por SAMS

o Cloxacilina

Fecha Epicrisis : 06/02/2023 11:27

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 06-02-2023 11:27:41

- Shock hipovolémico ¿ sangrado digestivo / 05/02/2023
- o Soporte transfusional
- o Profundización de sus fallas orgánicas

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J: NO

fallecido

Plan Post Alta

CERTIFICADO DE DEFUNCION

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Guillermo Molina Mancero
Médico Tratante (Staff)